Bilan biologique — valeurs usuelles françaises

Valeurs usuelles de l'adulte en unités SI, cible INR sous AVK fixée par le.la prescripteur.rice, pièges d'unités et repères infirmiers, pour réviser en IFSI

Clairance

Référentiel 2026 (entrant.e.s à partir de septembre 2026) : UE en lien, UE B.1 « Sciences biomédicales » (S1, S2) et UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » (examens biologiques en S1, prélèvement veineux en S2), selon l'offre de formation publiée par l'Université de Bourgogne Europe

⚠ PIÈGE Les valeurs usuelles varient selon les laboratoires
Interpréter un résultat avec les valeurs imprimées sur **le compte rendu du laboratoire** : c'est lui qui fait foi. Les valeurs usuelles de cette fiche, pour réviser, viennent d'une liste nationale de l'adulte publiée en **2009** (Conseil scientifique des concours de l'internat en pharmacie, « Valeurs biologiques usuelles », diffusé par le CNG).

Valeurs usuelles de l'adulte

Examen	Milieu	Valeurs usuelles	Autre écriture
Ionogramme et calcium			
Sodium (Na^+)	Pl	135–145 mmol/L	
Potassium (K^+)	Pl	3,5–4,5 mmol/L	
Chlorure (Cl^-)	Pl	95–105 mmol/L	
Bicarbonates (HCO_3^-)	Pl	23–27 mmol/L	
Calcium total	Se ou Pl	2,20–2,60 mmol/L	88–104 mg/L
Rein			
Urée	Se ou Pl	2,5–7,5 mmol/L	0,15–0,45 g/L
Créatinine, homme	Se ou Pl	60–115 µmol/L	7–13 mg/L
Créatinine, femme	Se ou Pl	45–105 µmol/L	5–12 mg/L
Clairance de la créatinine (pour 1,73 m²)		1,50–2,30 mL/s	90–140 mL/min
Glucose			
Glucose	Pl	3,90–5,50 mmol/L	0,70–1,00 g/L
HbA1c (part de l'Hb totale)	Sg	< 0,06	< 6 %
NFS (hémogramme)			
Hémoglobine, homme	Sg	130–170 g/L	
Hémoglobine, femme	Sg	120–160 g/L	
Hématocrite, homme	Sg	0,42–0,54	42–54 %
Hématocrite, femme	Sg	0,37–0,47	37–47 %
Hématies, homme	Sg	4,5–5,7 T/L	
Hématies, femme	Sg	4,2–5,2 T/L	
Leucocytes	Sg	4,0–10,0 G/L	
Polynucléaires neutrophiles	Sg	2–7,5 G/L	
Plaquettes	Sg	150–450 G/L	
Hémostase			
Taux de prothrombine (TP)	Pl	70–130 %	
TCA (rapport malade/témoin, sans unité)	Pl	0,80–1,20	
Fibrinogène	Pl	2–4 g/L	
Inflammation			
CRP (protéine C réactive)	Se	< 5 mg/L	
Bilan hépatique et protéines			
ASAT	Se	< 35 UI/L	
ALAT, homme	Se	< 45 UI/L	
ALAT, femme	Se	< 34 UI/L	
GGT, homme	Se	< 55 UI/L	
GGT, femme	Se	< 38 UI/L	
Bilirubine totale	Se ou Pl	< 17 µmol/L	< 10 mg/L
Albumine	Se	38–48 g/L	
Protéines totales	Se	65–80 g/L	
INR sous AVK : cible fixée par le.la prescripteur.rice			
INR sous AVK, cible la plus courante		2–3	
INR sous AVK, certaines atteintes valvulaires		3–4,5	

Milieu : Pl plasma, Se sérum, Sg sang. « Autre écriture » : seconde unité donnée par la source (équivalence arrondie). G/L = 10^9/L ; T/L = 10^{12}/L. Valeurs de 2009, indicatives : elles varient selon le laboratoire.

Fonction rénale : le DFG estimé

Le **DFG estimé** (DFGe) se calcule à partir de la créatininémie (formule CKD-EPI chez l'adulte) et s'exprime en mL/min/1,73 m². DFGe < 60 pendant plus de 3 mois : maladie rénale chronique de stade 3 ou plus. DFGe ≥ 90 : DFG normal ou augmenté (stade 1 si marqueurs d'atteinte rénale).

Pièges d'unités

⚠ PIÈGE Même examen, deux unités
La même glycémie s'écrit 3,90–5,50 mmol/L ou 0,70–1,00 g/L ; la créatinine (homme) 60–115 µmol/L ou 7–13 mg/L. Lire l'unité avant de comparer un résultat à une norme.

⚠ PIÈGE Fraction ou pourcentage
Hématocrite 0,42 = 42 % ; HbA1c < 0,06 = < 6 %. Même valeur, deux écritures (× 100).

⚠ PIÈGE TP, INR, TCA : trois écritures
TP en %, INR sans unité, TCA en **rapport** malade/témoin. Ne pas comparer un TP à une cible d'INR.

✓ EXEMPLE Deux calculs
TCA : 45 s ÷ 30 s = 1,50 (au-dessus de 1,20).
Clairance : 1,50 mL/s × 60 = 90 mL/min.
Valeurs d'exercice (TCA), pas des résultats de patient.e.

Repères infirmiers

+ NOTE CLINIQUE Kaliémie élevée et hémolyse
Kaliémie élevée = au-dessus de l'intervalle du compte rendu du laboratoire. Par prudence, **la signaler d'abord**, selon le protocole du service. L'hyperkaliémie se définit par un potassium plasmatique > 5,5 mmol/L. Une hémolyse du prélèvement peut donner une fausse hyperkaliémie : un nouveau prélèvement de contrôle, sans garrot, peut être prescrit. Ce contrôle ne retarde pas le signalement.

+ NOTE CLINIQUE INR sous AVK
La cible est fixée par le.la prescripteur.rice selon l'indication : 2 à 3 le plus souvent, 3 à 4,5 pour certaines atteintes valvulaires (prothèse mécanique mitrale notamment). **Au-dessus de la cible** : surdosage, risque hémorragique. **Au-dessous de la cible** : effet anticoagulant insuffisant, risque de thrombose. Dans les deux cas, signaler selon le protocole.

Sources : Conseil scientifique des concours de l'internat en pharmacie, « Valeurs biologiques usuelles », V8, diffusé par le CNG (19.11.2009) ; VIDAL Recos, « AVK (traitement par) » (21.10.2025) ; VIDAL Actualités, « L'hyperkaliémie, une origine médicamenteuse fréquente » (10.05.2022) ; VIDAL Actualités, « Estimation du débit de filtration glomérulaire : quelle formule utiliser ? » (20.10.2022) ; La Revue du Praticien Médecine générale, « Stades de la maladie rénale chronique » (15.04.2022) ; La Revue du Praticien, « Hyperkaliémie modérée en ville : quelle cause évoquer ? » (03.2026).

Rédaction assistée par IA ; contenu vérifié et validé par le vendeur. · Outil de révision. Il complète vos cours et ouvrages de référence, il ne les remplace pas. · Ne remplace ni les protocoles de votre service, ni la prescription médicale, ni l'avis d'un.e professionnel.le de santé.